B. Les personnes décédées

La mort est définie comme « un arrêt cardiaque persistant avec une absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, une abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et enfin une absence totale de ventilation spontanée ».

Le constat de la mort, excepté dans quelques cas définis ci-dessous, est de la compétence exclusive d'un médecin. Les sapeurs-pompiers ont donc obligation de pratiquer les gestes de réanimation jusqu'au constat de la mort par un médecin ou sur la demande du médecin coordinateur. Pendant la réanimation, ils peuvent évoquer la gravité de la situation avec l'entourage, mais l'annonce du décès est de la compétence du médecin.

Les secours doivent toujours garder une attitude correcte et digne, en rapport avec la gravité du moment (cf. chapitre 10).

B.1 Les cas de décès certains

Les sapeurs-pompiers peuvent affirmer la réalité d'un décès face à au moins l'une de ces trois circonstances :

- la décapitation (tête séparée du tronc) ;
- la putréfaction (signes de décomposition du cadavre) ;
- la raideur cadavérique (absence de respiration et de circulation avec rigidité de l'ensemble des articulations chez une personne non vue vivante au cours de la dernière heure).

Dans ces circonstances, aucune manœuvre de réanimation n'est entreprise.

Les situations d'arrêt cardiaque accompagnées d'importants délabrements crâniens avec perte de matière cérébrale peuvent être assimilées à une décapitation. Si ce traumatisme crânien date de moins d'une heure, le CA prend contact avec le médecin coordinateur qui évalue la possibilité de survie ou de don d'organe avant d'arrêter les manœuvres de RCP.

Dans tous les cas de décès certain, la coordination médicale est contactée pour arrêter l'équipe médicale le cas échéant, évaluer la pertinence de demande de police et décider qui fera le certificat de décès (médecin traitant, médecin de garde…).

B.2 Les morts suspectes

En l'absence de signes de violence, la découverte d'un cadavre :

- en lieu public ;
- en lieu privé : décès inattendu, sans explication physiologique (personne âgée) ou pathologique (phase terminale, multiples pathologies cardiovasculaires, respiratoires, personne grabataire…) ;

doit toujours faire supposer une mort suspecte.

Le médecin coordinateur est contacté pour évaluer la situation et savoir si la police doit être demandée quand il n'y a pas d'équipe médicale sur les lieux.

Les sapeurs-pompiers doivent alors demander la police et tout faire pour éviter que les indices nécessaires à l'enquête de la police ne soient effacés.

Dès la constatation du décès, le périmètre doit être largement balisé et évacué.

Toute modification de l'environnement (ouverture de porte, de fenêtre coupure de gaz, d'électricité…), de la position de la victime (dégagement d'urgence, simple retournement pour effectuer une RCP) ou de la tenue de la victime (déshabillage pour effectuer des manœuvres de réanimation) doivent être signalés aux enquêteurs.

Ce sont les forces de l'ordre qui doivent prévenir la famille du défunt si elle n'est pas sur place.

B.3 Le décès après réanimation

Si un obstacle médico-légal est posé par le médecin, l'intervention des forces de l'ordre est obligatoire.

B.4 Le décès sur la voie publique

Une victime décédée sur la voie publique doit être prise en charge par les forces de police après intervention directe ou non de l'officier de police judiciaire. La personne décédée est alors dirigée sur une structure d'accueil spécialisée (institut médico-légal, funérarium).

En attendant l'évacuation du corps et en l'absence de contre-indication (brouillage d'éléments de la scène d'un crime par exemple), les sapeurs-pompiers recouvrent le corps d'un drap, ou en accord avec la police, le mettent dans une bâche prévue à cet effet.